



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : مجدولين مجدي ميخائيل عطيه

العنوان : 45 شارع محمد نجاح
أيوب

المحافظة : القاهرة

رقم البطاقة : 27807030101246 رقم التليفون : 01200760039

تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 03-07-1978 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : اورام ليمفاويه

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : اورام ليمفاويه

خطة العلاج : أبحاث أورام رنين مغناطيسي علي الفقرات القطنيه بالصبغه

قسم العلاج :
الاورام

[12771]

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني

الاسم : د/ندى حسن

الاسم : د/نرمين رمضان

الوظيفة :

الوظيفة :

الوظيفة :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة

رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... /د. /د. /د. /د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

قسم :

جهة العلاج :

نفقات :

ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: مجدولين مجدي ميخائيل عطيه National ID: 27807030101246	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

A patient of lymphoma for Contrast-enhanced MRI of the lumbar spine

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
 بطاقة تحقيق الشخصية
 مبدولين
 مجدى مبدولين عطيه
 ٤٥ ش محمد نجاح اويون
 السرج - القاهرة
 ١٩٧٨.٧.٢٣ ٢٧٨.٠٧.٠١.٠١٢٤٦
 IT6212493

٢٠٣٧/٠٢ ٢٧٨.٧.٢٣.٠١.٠١٢٤٦
 حصنة ش بنو حجرة
 الشى مسيحية
 عبد السلام سحابة زكى مكار
 انشطة سارية حتى ٢٠٣٨/٠٢/١٠
 ١

Farid Habib Hospital



مستشفى فريد حبيب

Opinion :

Avidly enhancing dumbbell shaped intradural extra medullary lesion extending to right neural exit foramina of C5-6 & C6-7 with large extra spinal component , marked compression & displacement of cervical cord ??? suggesting cervical Schwannoma for clinical & histopathological correlation .

Right vertebral artery seen compressed by lesion for clinical correlation .

Early degenerative changes with posterior disc lesions .

Neck muscle spasm.

Dr:Samaa Gamal,FEBR

DR. RAYMOND ADILY-MD

Farid Habib Hospital



مستشفى فريد حبيب

Patient Name: MAGDOULEEN Magdy Michael	Patient ID: 404874
Age: 48 Year(s), 2 Month(s)	Report Date: 16/09/2026
Study Description:	Procedure: C - S

MRI EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE:

Technique of examination:

1. Sagittal T1 & T2 WIs
2. Axial T1, T2 & Flair WIs

MRI Findings :

- Straightened cervical curvature.
- Normal dimensions of the bony cervical spinal canal.
- Reduced hydration of the cervical discs, denoting early degeneration .
- A vividly enhancing dumbbell shaped intradural extramedullary mass infiltrating C6 extends from spinal canal through the C5-6 & C6-7 right neural exit foramen with large extra spinal component . It is hyperintense on T2 weighted imaging and isointense to cord on T1. Marked compression of Spinal cord with displacement to the left side by the mass.
- Right vertebral artery seen compressed by lesion .
- C3-4 mild posterior disc bulge seen indenting the subarachnoid space, effacing the anterior aspect of the cord and mildly encroaching on the corresponding neural exit foramina .
- C4-5 mild posterior disc bulge seen indenting the subarachnoid space, barely touching the anterior aspect of the cord and mildly encroaching on the corresponding neural exit foramina more on left side .
- Normal marrow signal of the other imaged vertebrae.

Patient Name: MAGDOULEEN Magdy Michael	Patient ID: 404874
Age: 48 Year(s), 2 Month(s)	Report Date: 16/09/2026
Study Description:	Procedure: CERVICAL SPINE

NON-ENHANCED CT SCAN OF CERVICAL SPINE WITH SAGITTAL RECONSTRUCTION REVEALED: -

Findings:

- Straightening of cervical lordosis .
- Cervical spondylotic changes with antemarginal osteophytes , narrowing of intervertebral disc spaces of lower cervical levels & posterior osteophytes .
- mass lesion eroding border of right neural exit foramina & dorsal contour of C6 with extra spinal extension .
- Normal osseous texture of the other vertebral bodies & their neural arches.
- Normal appearance of the scanned zygo-apophyseal and neurocentral joints.

Opinion :

- mass lesion eroding border of right neural exit foramina & dorsal contour of C6 with extra spinal extension better assessed in MRI with contrast study for clinical & histopathological correlation .
- Spondylodegenerative changes with narrowing of intervertebral disc spaces of lower cervical levels with posterior osteophytes .
- Neck muscle spasm .

dr:samaa gamal,FEBR
DR. RAYMOND ADLY-MD

Patient Name: MAGDOULEEN Magdy Michael	Patient ID: 404874	
Age: 48 Year(s), 2 Month(s)	Report Date: 22/09/2026	
Study Description:	Procedure: C - S	

MRI EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE:

Technique of examination:

1. Sagittal T1 & T2 WIs
2. Axial T1, T2 & Flair WIs

MRI Findings : post-operative study for mass lesion excision and internal fixation of posterior element revealed :

- Newly formed operative bed subcutaneous & posterior aspect collection of fluid signal intensity in all pulse sequences with no evidence of post-contrast enhancement , extending through spinal canal to anterior epidural space .slightly compressing right aspect of spinal cord ,, associated edematous changes of surrounding paraspinal muscles ,, likely of post-operative sequelae for clinical correlation .
- Regressive course regarding previously reported vividly enhancing dumbbell shaped intradural extramedullary mass infiltrating C6 now anterior part of lesion & smaller part seen through right exit foramina. Marked regressive course regarding compression of Spinal cord .
- Right vertebral artery seen compressed by the lesion .
- Straigtened cervical curvature.
- Normal dimensions of the bony cervical spinal canal.
- Reduced hydration of the cervical discs, denoting early degeneration .
- C3-4 mild posterior disc bulge seen indenting the subarachnoid space, effacing the anterior aspect of the cord and mildly encroaching on the corresponding neural exit foramina .

- C4-5 mild posterior disc bulge seen indenting the subarachnoid space, barely touching the anterior aspect of the cord and mildly encroaching on the corresponding neural exit foramina more on left side .
- Normal marrow signal of the other imaged vertebrae.

Opinion :-

Newly formed operative bed subcutaneous & posterior aspect collection of fluid signal intensity in all pulse sequences with no evidence of post-contrast enhancement , extending through spinal canal to anterior epidural space ,slightly compressing right aspect of spinal cord ,, associated edematous changes of surrounding paraspinal muscles ,, likely of post-operative sequelae for clinical correlation .

Regressive course regarding previously reported Avidly enhancing dumbbell shaped intradural extra medullary lesion with marked regressive course regarding compression & displacement of cervical cord as described above .

Early degenerative changes with posterior disc lesions .

Right vertebral artery seen compressed by the lesion for clinical correlation .

Neck muscle spasm.

Dr::Samaa Gamal,FEBR

DR. RAYMOND ADLY-MD

Dr.
Elia Anis Ishak
M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis
M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : مجولين مجدى ميخائيل عطيه
Age : 48 Y : 2 M : 1 D Gender : Female
Referred By Prof. Dr. : مينا منير
Clinical Diagnosis : Extra-axial extradural cervical lesion.
Nature of Specimen : Biopsy.
Receiving Date : 2026-09-15 Patient ID : 798644

Analysis ID : 1095722
Conf. Code : 9389

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Multiple fragmented rubbery grayish white tissue pieces, collectively measured 2.5x2.5 cm, totally submitted.

Microscopic :

Sections examined from the specimen received revealed pieces of moderate cellular tumor tissue formed of spindle cells showing moderate nuclear pleomorphism and hyperchromasia, arranged in fascicles. Mitotic activity count about 21/10 HPF. No necrosis.

Diagnosis :

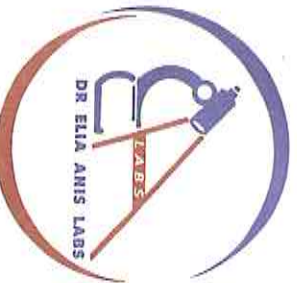
Cervical lesion, Biopsy, SPINDLE CELL SARCOMA.
- CASE FOR IMMUNOPHENOTYPING.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

Shady Elia

Elia anis



This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void .

جمهورية مصر العربية
 بطاقة تخليق الشخصية

مبدولين
 مجدى مبدولين عطيه
 ٤٥ ش محمد نجاح اويون
 السرج - القاهرة

١٩٧٨.٧.٢٣ ٢٧٨.٠٧.٠٣.٠١.٠١٢٤٦
 IT6212493

٢٠٣٧/٠٢ ٢٧٨.٧.٢٣.٠١.٠١٢٤٦
 حصنة شيتوه حجرة
 الشى مسيحية
 عبد السلام سحابة زكى مكار
 انشطة سارية حتى ٢٠٣٨/٠٢/١٠

مروجية



FARID HABIB HOSPITAL
مستشفى فريد حبيب

0133277
تقرير طبي ميداني (قسم الطوارئ)



Primary Medical Report (Emergency Department)

Name: محمود محمد عيسى عيسى الاسم:

Report date: 13/9/2024 تاريخ التقرير:

Visit date: تاريخ الزيارة:

Destination: الجهة التابع لها:

Medical Report: التقرير الطبي:

تمتد المدة إلى الطوارئ تعاني من آلام في البطن والكتف
والعضو في نسيب وجود رورع بالجلد الشوكي في الفقرة L5/S1
سبب عدم الاتزان والضعف العام. يحتاج المريض إلى تدخل
الطبيب الداخلي ودخول العمليات الجراحية لاستئصال الورم بالصلب النخاعي
بالفقرة L5/S1 لتفريغ الضغط عن الحبل الشوكي وتسهيل العود إلى
الأنشطة الطبيعية. وسأقوم بتأليف تقرير طبي تفصيلي في وقت لاحق.

أحمد عبد الله

الطبيب المعالج: د. أحمد عبد الله
د. أحمد عبد الله



- لا يعتبر هذا التقرير الطبي نهائياً
- يحتج المريض إلى الالتزام بالعلاج الدوائي والتعديلات الغذائية والإبرام بالعناية بالمعدة الخارجية مع استشارة التخصص في الموعد المحدد من قبل الطبيب المعالج في قسم الطوارئ وذلك لاستكمال الفحوصات اللازمة والفحص للتأكد من عدم وجود ما يهدد
- للمريض الطبي النهائي.
- لا يعتبر هذا التقرير ساري المفعول بوضع عليه ختم المستشفى

الإجراءات الموصى بها تخضع لموافقة لجنة العمل ويتم توصيتها حسب الحالة الطبية للمريض / المريضة وقت الكشف بالطبيب
مد يله العبدور - الحي الخامس - قطعة رقم 5 - بلوك 11.81 تليفون: 01147147147 - 01147147147

Opinion :

Avidly enhancing dumbbell shaped intradural extra medullary lesion extending to right neural exit foramina of C5-6 & C6-7 with large extra spinal component , marked compression & displacement of cervical cord ??? suggesting cervical Schwannoma for clinical & histopathological correlation .

Right vertebral artery seen compressed by lesion for clinical correlation .

Early degenerative changes with posterior disc lesions .

Neck muscle spasm.

Dr:Samaa Gamal,FEBR

DR. RAYMOND ADILY-MD

Patient Name: MAGDOULEEN Magdy Michael	Patient ID: 404874
Age: 48 Year(s), 2 Month(s)	Report Date: 16/09/2026
Study Description:	Procedure: C - S

MRI EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE:**Technique of examination:**

1. Sagittal T1 & T2 WIs
2. Axial T1, T2 & Flair WIs

MRI Findings :

- Straightened cervical curvature.
- Normal dimensions of the bony cervical spinal canal.
- Reduced hydration of the cervical discs, denoting early degeneration .
- A vividly enhancing dumbbell shaped intradural extramedullary mass infiltrating C6 extends from spinal canal through the C5-6 & C6-7 right neural exit foramen with large extra spinal component . It is hyperintense on T2 weighted imaging and isointense to cord on T1. Marked compression of Spinal cord with displacement to the left side by the mass.
- Right vertebral artery seen compressed by lesion .
- C3-4 mild posterior disc bulge seen indenting the subarachnoid space, effacing the anterior aspect of the cord and mildly encroaching on the corresponding neural exit foramina .
- C4-5 mild posterior disc bulge seen indenting the subarachnoid space, barely touching the anterior aspect of the cord and mildly encroaching on the corresponding neural exit foramina more on left side .
- Normal marrow signal of the other imaged vertebrae.

Patient Name: MAGDOULEEN Magdy Michael	Patient ID: 404874
Age: 48 Year(s), 2 Month(s)	Report Date: 16/09/2026
Study Description:	Procedure: CERVICAL SPINE

NON-ENHANCED CT SCAN OF CERVICAL SPINE WITH SAGITTAL RECONSTRUCTION REVEALED: -

Findings:

- Straightening of cervical lordosis .
- Cervical spondylotic changes with antemarginal osteophytes , narrowing of intervertebral disc spaces of lower cervical levels & posterior osteophytes .
- mass lesion eroding border of right neural exit foramina & dorsal contour of C6 with extra spinal extension .
- Normal osseous texture of the other vertebral bodies & their neural arches.
- Normal appearance of the scanned zygo-apophyseal and neurocentral joints.

Opinion :

- mass lesion eroding border of right neural exit foramina & dorsal contour of C6 with extra spinal extension better assessed in MRI with contrast study for clinical & histopathological correlation .
- Spondylodegenerative changes with narrowing of intervertebral disc spaces of lower cervical levels with posterior osteophytes .
- Neck muscle spasm .

dr::samaa gamal,FEBR
DR. RAYMOND ADLY-MD

Patient Name: MAGDOULEEN Magdy Michael	Patient ID: 404874	
Age: 48 Year(s), 2 Month(s)	Report Date: 22/09/2026	
Study Description:	Procedure: C - S	

MRI EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE:

Technique of examination:

1. Sagittal T1 & T2 WIs
2. Axial T1, T2 & Flair WIs

MRI Findings : post-operative study for mass lesion excision and internal fixation of posterior element revealed :

- Newly formed operative bed subcutaneous & posterior aspect collection of fluid signal intensity in all pulse sequences with no evidence of post-contrast enhancement , extending through spinal canal to anterior epidural space .slightly compressing right aspect of spinal cord ,, associated edematous changes of surrounding paraspinal muscles ,, likely of post-operative sequelae for clinical correlation .
- Regressive course regarding previously reported vividly enhancing dumbbell shaped intradural extramedullary mass infiltrating C6 now anterior part of lesion & smaller part seen through right exit foramina. Marked regressive course regarding compression of Spinal cord .
- Right vertebral artery seen compressed by the lesion .
- Straigtened cervical curvature.
- Normal dimensions of the bony cervical spinal canal.
- Reduced hydration of the cervical discs, denoting early degeneration .
- C3-4 mild posterior disc bulge seen indenting the subarachnoid space, effacing the anterior aspect of the cord and mildly encroaching on the corresponding neural exit foramina .

- C4-5 mild posterior disc bulge seen indenting the subarachnoid space, barely touching the anterior aspect of the cord and mildly encroaching on the corresponding neural exit foramina more on left side .
- Normal marrow signal of the other imaged vertebrae.

Opinion :

Newly formed operative bed subcutaneous & posterior aspect collection of fluid signal intensity in all pulse sequences with no evidence of post-contrast enhancement , extending through spinal canal to anterior epidural space ,slightly compressing right aspect of spinal cord ,, associated edematous changes of surrounding paraspinal muscles ,, likely of post-operative sequelae for clinical correlation .

Regressive course regarding previously reported Avidly enhancing dumbbell shaped intradural extra medullary lesion with marked regressive course regarding compression & displacement of cervical cord as described above .

Early degenerative changes with posterior disc lesions .

Right vertebral artery seen compressed by the lesion for clinical correlation .

Neck muscle spasm.

Dr::Samaa Gamal,FEBR

DR. RAYMOND ADLY-MD

إسم المريض ثلاثي:
رقم الملف:

تقرير طبي

السيد/

تخية طبية ويعد،

بشان تقرير طبي للمريض:

إيلاء للطلاب المقدم من

رقم طبي

نشر ف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته:

تاريخ وساعة الخروج

تاريخ وساعة الدخول

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه:

Deretha Kadut

Masafahog Palt

Camil
Post alhalakut Palt

Alhads wa Mt Pa

for all the

تحريراً في

الوقت:

الطبيب المعالج

يتم

Dr.

Elia Anis Ishak

M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology , USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.

Shady Elia Anis

M. Sc. MD Pathology , Ass. Prof. of Pathology , Cairo University
Fellow , Mass General Hospital , Harvard USA
Member , United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : مجولين مجدى ميخائيل عطيه

Analysis ID : 1095722

Age : 48 Y : 2 M : 1 D

Gender : Female

Conf. Code : 9389

Referred By Prof. Dr. : مينا منير

Clinical Diagnosis : Extra-axial extradural cervical lesion.

Nature of Specimen : Biopsy.

Receiving Date : 2026-09-15

Patient ID : 798644

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Multiple fragmented rubbery grayish white tissue pieces, collectively measured 2.5x2.5 cm, totally submitted.

Microscopic :

Sections examined from the specimen received revealed pieces of moderate cellular tumor tissue formed of spindle cells showing moderate nuclear pleomorphism and hyperchromasia, arranged in fascicles. Mitotic activity count about 21/10 HPF. No necrosis.

Diagnosis :

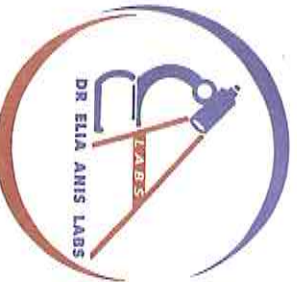
Cervical lesion, Biopsy, SPINDLE CELL SARCOMA.
- CASE FOR IMMUNOPHENOTYPING.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

Shady Elia

Elia Anis



This report is electronically signed , any abrasion or modification would render it void .

تقرير طبي

اسم المريضة : مجولين مجدي ميخائيل عطيه	تاريخ التقرير: ٢٠٢٦/٩/٢٥
تاريخ الدخول : ٢٠٢٦/٩/٢١	تاريخ الخروج: ٢٠٢٦/٩/٢٥
النوع : انثى	الرقم الطبي : ٤٠٤٨٧٤
الطبيب المعالج : د/ مينا منير رزق	السن : ٤٨ سنة
	جهة التعاقد : كريزي اليكترونيك ٥٠%

التشخيص المبدئي: حضرت المريضة الي قسم جراحة المخ والاعصاب تعاني من ضعف بالاطراف الاربعه وعدم القدرة علي المشي.

ملخص الحالة : تم حجز المريضة بالقسم الداخلي وبالكشف المبني وعمل الفحوصات والاشعة اللازمة اشعة رنين علي الفقرات تم علاج تحفظي دوالي ولم يتم اجراء اي تدخل جراحي وتم متابعة حالة المريضة لحين استقرارها وتقرر عمل خروج للتحسن .

تحتاج المريضة : الي الاجازة لمدة شهر و المتابعة بالعيادات الخارجية.

وتم تقديم هذا التقرير المبني للمريض عند خروجه من المستشفى .

المدير الفني

الطبيب المعالج

عند ع
٢٠٢٦/٩/٢٥



Name
Patient Info.
Department
Referred By

مجنولين مجدى ميخائيل عطيه
Female 48 Y - 2 M - 24 D
الداخلي الدور الثاني
مينا منير رزق

Patient ID
Registered
Validation Date
Reporting Date

404874
13/9/2026 09:56:13 PM
14/9/2026 10:33:09 AM
21/9/2026 12:51:32 PM

Biochemistry Report

Reference Range

Kidney Function
Creatinine

: 0.7

0.6 - 1.2

mg/dL

Signature
Dr.Hanan



Name
Patient Info.
Department
Referred By

مجدولين مجدي ميخائيل عطيه
Female 48 Y - 3 M - 2 D
Outpatient
Doctor Lab

Patient ID
Registered
Validation Date
Reporting Date

404874
21/9/2026 01:12:54 PM
21/9/2026 01:53:49 PM
21/9/2026 01:59:20 PM

Kidney Function

Creatinine

:

0.6

Biochemistry Report

Reference Range

0.6 - 1.2

mg/dL

Signature
Dr.Hanan